



APV 個案-面對多重神經議題與單親無資源的處遇策略及思維看見

主講人：新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心

社工督導賴渝淇

執行摘要

本次分享一覽



案例背景

APV（青少年對家長施暴）合併多重神經議題，單親無資源，是第一線社工最棘手的處遇情境之一。



跨網絡合作

透過司法、醫療、社福三大網絡的協調整合，以家防中心成保組為核心樞紐，建立穩定的支持體系。



三大實務策略

非暴力抵抗（NVR）定錨、動態安全計畫與 **Time Out** 機制、制度資源補位創造喘息空間。



思維翻轉

導入「雙案主」框架與司法介入模式，協助社工在有限改變中守住安全底線，並重視自我照顧。

網絡合作圖(案例一)



網絡合作圖(案例二)





故事導入：APV 困境三重奏

當家庭暴力的施暴者是自己的孩子，當家長既是受害者也是唯一照顧者——這樣的現場，考驗的不只是方法，更是每一位社工的專業底線與心理承載力。

✿ 案主樣態

單親家庭（印尼籍媽媽／工程師爸爸），獨力照顧合併 ADHD、思覺失調、癲癇等多重神經議題的青少年。

⚙️ 系統困境

無親友替代資源、家長愧疚感深重，兒少以自傷、跳樓、暴力作為情緒勒索與控訴的手段。

😬 第一線焦慮

「不敢隔離（無處去）、不敢壓制（怕激怒引發自傷）、家長不敢放下（愧疚），社工到底能做些什麼？」



三種困境的交織

當孩子同時是「受害者」與「施暴者」

APV 施暴方往往背負多重診斷，家長情感上難以切割。

- 疾病是背景，非暴力免責牌
- 愧疚感導致「無底線順從」
- 暴力被解讀為症狀，模糊責任界線

系統資源的雙重缺口

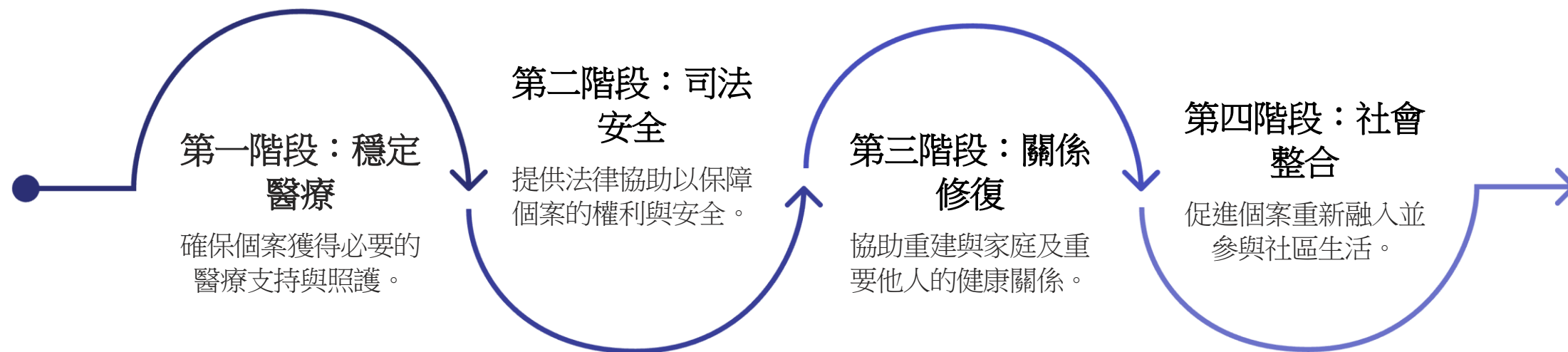
照顧壓力與資源匱乏同時夾擊，親友支持幾乎為零。

- 無替代照顧者，家長無法喘息
- 醫療、司法、社福串聯跟不上突發狀況
- 安置≠改變核心議題

疾病與暴力的界線：

「抓大放小」的處遇邏輯

精神或神經議題是理解行為的重要脈絡，但絕非暴力行為的合法免責牌。清楚劃定界線，才能在同理之餘守住安全底線。



處遇優先順序的清晰化，幫助社工與家庭在混亂中找到結構，避免因同情而跳過關鍵的安全中斷步驟。



觀念翻轉

翻轉框架：導入「雙案主」與司法介入模式



告別 IPV 二元對立

家長同時承受暴力與照顧責任，兒少同時是需要被約束的施暴者，也是需要被保護的脆弱個體。唯有「雙案主」視角，才能避免服務的片面性。



司法監督作為外在防護網

聲請保護令（禁止暴力、命令完成心理輔導），結合少年保護官與法律約束。司法介入不是懲罰，而是讓「改變」有外在框架可以依附。



加害人處遇與關係修復並行

在司法約束下，同步啟動兒少心理輔導與親子關係修復，讓改變在有結構的容器內緩慢發生。

實務策略一： 非暴力抵抗（**NVR**）與家長定錨

核心態度的宣示

陪伴家長找回自己作為父母的聲音，清楚向孩子喊出：

「我無法強迫你，但我絕不接受暴力，且我不會放棄你。」

這句話的力量在於同時傳遞兩個訊息：**界線與連結**。不是威脅，也不是屈服，而是穩定地存在。

維持穩定，專注中斷

在衝突高峰期，管教往往無效且危險。**NVR** 的核心是教導家長：

- 不在情緒高張時爭辯或說教
- 不被挑釁激怒，停止防衛性回擊
- 放棄「無底線順從」的護短模式
- 像「錨」一樣穩定在場，而非隨波逐流

家長的「定錨」不是冷漠，而是高度清醒的在場。

實務策略二： 動態安全計畫與 Time Out 機制

針對多重神經議題兒少的特性，安全計畫必須具備動態彈性——在系統冷靜時預先約定，在衝突激化時有路徑可循。

1

平時約定暗號

在家庭狀態穩定時，共同約定「暫停暗號」與空間隔離規則，讓兒少與家長都清楚衝突升級時的退出路徑。

2

安全撤離執行

當衝突激化，家長執行「退至安全空間」或「門口訪談」策略，減少正面衝突，保護自身安全。

3

通報與醫療護送

立即報警，利用警政與醫療戒護系統護送兒少就醫，將危機轉化為醫療介入的契機，而非讓家長獨自承擔。

 安全計畫不是一張紙，而是需要反覆演練、隨情境調整的活的協議。社工的角色是陪伴家庭把計畫從「知道」變成「做得到」。

實務策略三：

以制度資源補位，創造家長喘息空間

單親家庭缺乏親友支持網絡時，社工的任務是成為資源連結的橋梁，將正式系統轉化為家長喘息的空間。

醫療資源

日間留院、精神科門診追蹤、醫療戒護護送，讓醫療系統接住部分照顧責任。

社福與康復資源

康復之家、社區日間資源中心、緊急喘息服務，為家長創造物理上的暫時脫離。

長照與居服

部分個案可連結長照居服資源，補足家長照顧能量，降低照顧壓力導致的情緒崩潰風險。

急難補助

短期急難補助與生活扶助，緩解經濟壓力，讓家長在物質層面稍獲喘息，才有餘力面對照顧挑戰。

哪怕每週只為家長爭取到 **2 小時的真喘息**，都是防止暴力爆發與家長崩潰的關鍵保險閥。



陪伴社工面對「有限改變」與「不可控」

解構「完美處遇」迷思

APV 案件的改變是非線性的。衝突持續、兒少反覆進出醫院、家長情緒崩潰——這些都是常態，而非社工的失敗。習得無助感是第一線社工最常見的職業傷害。

重新定義貢獻

「在司法約束與網絡陪伴下守住風險本身，就是非常具體的改變。」守住安全底線，就是貢獻。

區分可控與不可控

督導需要協助社工清晰區分兩個領域：

- 社工能控制的：專業態度、安全計畫品質、司法聲請時機、網絡協調效能
- 社工無法控制的：疾病病程、家庭歷史動力、兒少的選擇

這個區分是保護社工免於替代性創傷的核心思維工具。社工能給予的，是穩定的陪伴與結構性的支持，而非奇蹟式的改變。

結語：在 **APV** 的風暴中，跨網絡的合作及陪伴是家庭走過低谷的力量

「透過跨網絡的理解、合作與司法約束，我們不僅為家長與孩子重新定錨，更在有限改變的實務現場，共同築起防禦風險的安全防線。」

醫療穩定優先

神經議題需要醫療系統的持續接住，安全才有基礎。

司法作為結構

保護令與少年司法是外在防護網，讓改變有框架可依附。

雙案主並行服務

家長與兒少同時是服務對象，缺一不可。

守住底線即貢獻

社工的定錨與穩定存在，本身就是改變的一部分。

